Referensi

No	Topik	Referensi (Vancouver)	Jenis dan tingkat bukti	Catatan EBM
1	Malaria	World Health Organization. WHO guidelines for malaria, 30 November 2024. Geneva: WHO; 2024. DOI: 10.2471/B09146. Halaman pembaruan resmi: WHO Global Malaria Programme	Pedoman WHO berbasis GRADE, "living guideline" yang terus diperbarui	Pedoman ini membandingkan antara lain DHP vs artemeter-lumefantrin dan artesunat vs kina pada malaria berat. Pencarian juga menampilkan versi lebih baru (13 Agustus 2025 dan September 2026 di MESA); **selalu cek versi terakhir** sebelum mengutip dosis
2	Dengue	World Health Organization, TDR. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. New edition. Geneva: WHO; 2009. ISBN 978-92-4-154787-1. Halaman WHO	Pedoman WHO (konsensus pakar, edisi 2009)	Sumber klasifikasi **dengue dengan warning signs dan dengue berat** serta terapi cairan di slide. Klasifikasi DF/DHF derajat I sampai IV ("WHO 2011" di slide) berasal dari dokumen WHO regional lain yang belum saya temukan
3	Tuberkulosis	World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis: Module 4: treatment and care. Geneva: WHO; 2025. ISBN 978-92-4-010724-3. Halaman WHO; teks lengkap di NCBI Bookshelf	Pedoman WHO berbasis GRADE	Memuat rejimen 6 bulan standar dan **rejimen 4 bulan (2HPMZ/2HPM) untuk usia 12 tahun ke atas**, serta rekomendasi steroid tambahan pada meningitis TB dan perikarditis TB. Slide memakai 2HRZE/4HR, yang tetap menjadi pilihan standar
4	Tuberkulosis (Indonesia)	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis. Jakarta:	Pedoman nasional (PNPK)	Dasar klasifikasi TB, alur diagnosis, dan OAT yang dipakai di slide Indonesia; slide juga merujuk PDPI 2021 dan Permenkes 2016 yang tidak saya telusuri

No	Topik	Referensi (Vancouver)	Jenis dan tingkat bukti	Catatan EBM
		Kemenkes RI; 2019. PDF Kemenkes		
5	Demam tifoid	Kuehn R, Stoesser N, Eyre D, Darton TC, Basnyat B, Parry CM. Treatment of enteric fever (typhoid and paratyphoid fever) with cephalosporins. Cochrane Database Syst Rev. 2022;(11):CD010452. DOI: 10.1002/14651858.CD010452.pub2	Systematic review RCT (Cochrane)	Seftriakson tampaknya setara dengan azitromisin, fluorokuinolon, atau kloramfenikol (**bukti sangat rendah sampai rendah**); sefiksim juga dapat dipakai tetapi mungkin kurang efektif daripada fluorokuinolon. Sesuai dengan slide yang menaruh sefiksim sebagai alternatif
6	Leptospirosis	Win TZ, Han SM, Edwards T, Maung HT, Brett-Major DM, Smith C, et al. Antibiotics for treatment of leptospirosis. Cochrane Database Syst Rev. 2024;(3):CD014960. DOI: 10.1002/14651858.CD014960.pub2; teks di PMC	Systematic review RCT (Cochrane)	**Penting:** review ini menyimpulkan bukti RCT belum cukup untuk mendukung atau menolak antibiotik pada leptospirosis (9 RCT, 1019 peserta). Doksisiklin dan penisilin G di slide bersumber dari praktik dan pedoman, **bukan dari bukti RCT yang kuat**
7	Kolera	Leibovici-Weissman Y, Neuberger A, Bitterman R, Sinclair D, Salam MA, Paul M. Antimicrobial drugs for treating cholera. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(6):CD008625. DOI: 10.1002/14651858.CD008625.pub2	Systematic review RCT (Cochrane), 39 RCT dengan 4623 peserta	Antibiotik memperpendek diare sekitar satu setengah hari dan mengurangi kebutuhan cairan; **azitromisin dan tetrasiklin tampak lebih unggul**, pilihan disesuaikan resistensi lokal. Rehidrasi tetap terapi utama seperti di slide
8	Pneumonia komunitas dewasa	Metlay JP, Waterer GW, Long AC, Anzueto A, Brozek J, Crothers K, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia: an official clinical practice guideline of the American Thoracic	Pedoman profesi berbasis GRADE	Sesuai slide: **kortikosteroid tidak rutin**, istilah HCAP ditinggalkan, cakupan anaerob tambahan hanya bila ada abses paru atau empiema. Pedoman ini untuk dewasa non-imunokompromais di

No	Topik	Referensi (Vancouver)	Jenis dan tingkat bukti	Catatan EBM
		Society and Infectious Diseases Society of America. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(7):e45-e67. DOI: 10.1164/rccm.201908-1581ST		Amerika Serikat, sehingga tidak otomatis berlaku untuk anak
9	Rabies	World Health Organization. Rabies vaccines: WHO position paper, April 2018. Wkly Epidemiol Rec. 2018;93(16):201-20. Halaman WHO. Ringkasan: Vaccine. 2018;36(37):5500-3. DOI: 10.1016/j.vaccine.2018.06.061	Position paper WHO/SAGE berbasis GRADE	**Perbedaan dengan slide:** WHO 2018 memilih rejimen intradermal 2 situs pada hari 0, 3, 7 sebagai opsi hemat dosis dan waktu, dan orang yang pernah diimunisasi tidak butuh RIG. Jadwal IM 0-3-7-14(-28) di slide adalah jadwal konvensional; ikuti pedoman nasional bila ujian meminta jadwal Indonesia
10	Campak (vitamin A)	Huiming Y, Chaomin W, Meng M. Vitamin A for treating measles in children. Cochrane Database Syst Rev. 2005;(4):CD001479. DOI: 10.1002/14651858.CD001479.pub3; PubMed 16235283	Systematic review RCT (Cochrane)	**Dua dosis berturut-turut** (200.000 IU) menurunkan risiko kematian pada anak di bawah 2 tahun (RR 0,18) dan kematian akibat pneumonia; **dosis tunggal tidak terbukti**. Sesuai slide (hari 1 dan 2)
11	Hepatitis B kronik	World Health Organization. Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection. Geneva: WHO; 2024. ISBN 978-92-4-009090-3. Halaman WHO	Pedoman WHO berbasis GRADE	Pedoman 2024 **memperluas kelayakan terapi antiviral** dan memperkenalkan pemeriksaan HBV-DNA point-of-care, sehingga lebih luas daripada kriteria klasik di slide
12	Skistosomiasis	WHO guideline on control and elimination of human schistosomiasis. Geneva: World Health Organization; 2022. ISBN	Pedoman WHO berbasis GRADE dan	Praziquantel dianjurkan untuk semua yang terinfeksi, termasuk ibu hamil setelah trimester pertama dan ibu menyusui.

No	Topik	Referensi (Vancouver)	Jenis dan tingkat bukti	Catatan EBM
		978-92-4-004160-8. Halaman peluncuran WHO. Ulasan: Review of 2022 WHO guidelines on the control and elimination of schistosomiasis. Lancet Infect Dis. 2022. DOI: 10.1016/S1473-3099(22)00221-3	9 systematic review	Rincian dosis per spesies di slide tidak saya cek ulang

No	Topik	Referensi (Vancouver)	Jenis dan tingkat bukti	Catatan EBM ter
13	Tetanus	Rodrigo C, Fernando D, Rajapakse S. Pharmacological management of tetanus: an evidence-based review. Crit Care. 2014;18(2):217. DOI: 10.1186/cc13797; teks di PMC. Okoromah CAN, Lesi FEA. Diazepam for treating tetanus. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(1):CD003954. DOI: 10.1002/14651858.CD003954.pub2	Systematic narrative review dan Cochrane	Benzodiazepin tetap terapi andalan pengendali spasme (berdasar pendapat pakar karena uji klinis sulit dilakukan). **MgSO4: meta-analisis tidak menunjukkan manfaat mortalitas** (level A), jadi di slide perannya adjuvan untuk spasme dan disfungsi otonom, bukan penyelamat nyawa. Rute terbaik TIG (IM saja atau IM + intratekal) masih diperdebatkan
14	Hepatitis C	World Health Organization. Updated recommendations on treatment of adolescents and children with chronic HCV infection: policy brief. Geneva: WHO; 2022. ISBN 978-92-4-005271-0. Halaman WHO; berita WHO	Pedoman WHO berbasis GRADE	Terapi **DAA pangenotipik** (SOF/DCV, SOF/VEL, glecaprevir/pibrentasvir) untuk semua pasien HCV kronik termasuk anak usia 3 tahun ke atas. **Peginterferon + ribavirin pada slide sudah tidak menjadi pilihan modern**. Diagnosis kini juga boleh memakai RNA HCV point-of-care
15	COVID-19	Rochwerg B, Agoritsas T, Lamontagne F, et al. A living WHO guideline on drugs for covid-19. BMJ. 2020;370:m3379.	Pedoman WHO "living guideline" berbasis GRADE dan	Rekomendasi kuat **kortikosteroid sistemik pada COVID berat dan kritis**, rekomendasi bersyarat menolaknya pada

No	Topik	Referensi (Vancouver)	Jenis dan tingkat bukti	Catatan EBM ter
		DOI: 10.1136/bmj.m3379	living network meta-analysis	kasus non-berat; rekomendasi kuat menolak hidroksiklorokuin dan lopinavir-ritonavir; versi terbaru juga merekomendasikan nirmatrelvir/ritonavir untuk non-berat risiko tinggi dan remdesivir bersyarat untuk berat. Pedoman Kemenkes Desember 2020 di slide lebih tua, dan saya tidak menemukan vitamin C/D atau azitromisin dalam ringkasan rekomendasi WHO yang saya baca
16	Flu burung (influenza zoonotik)	World Health Organization. Clinical practice guidelines for influenza. Geneva: WHO; 2024. ISBN 978-92-4-009775-9. Ringkasan di MAGICapp. Ringkasan: BMJ. 2026;392:e087397. DOI: 10.1136/bmj-2025-087397; PubMed 41760115	Pedoman WHO berbasis GRADE	**Oseltamivir bersyarat direkomendasikan untuk influenza berat termasuk novel influenza A**; profilaksis (oseltamivir, zanamivir, laninamivir, baloxavir) bersyarat untuk semua yang terpapar influenza zoonotik. Sesuai arah slide (oseltamivir untuk suspek/probable); dosis di slide tidak saya cek
17	Leishmaniasis	World Health Organization. WHO guidelines on leishmaniases: treatment of visceral leishmaniasis and post-kala-azar dermal leishmaniasis in eastern Africa and South-East Asia. Geneva: WHO. Halaman WHO. WHO guidelines for the treatment of visceral leishmaniasis in HIV co-infected patients in East Africa and South-East Asia. Geneva: WHO; 2022. ISBN	Pedoman WHO berbasis GRADE dan systematic review	Pedoman ini regional (daerah *L. donovani*) dan untuk pasien HIV-negatif pada dokumen pertama. Untuk koinfeksi HIV, **kombinasi liposomal amfoterisin B + miltefosin** direkomendasikan di atas monoterapi. Leishmaniasis kutaneus dan mukokutaneus di slide tidak tercakup pedoman ini

No	Topik	Referensi (Vancouver)	Jenis dan tingkat bukti	Catatan EBM ter
		978-92-4-004829-4. Halaman WHO		
18	Tripanosomiasis Afrika	Lindner AK, Lejon V, Barrett MP. New WHO guidelines for treating rhodesiense human African trypanosomiasis: expanded indications for fexinidazole and pentamidine. Lancet Infect Dis. 2024. DOI: 10.1016/S1473-3099(24)00581-4. Pedoman asal: WHO. Guidelines for the treatment of human African trypanosomiasis. Geneva: WHO; 2024. ISBN 978-92-4-009603-5	Pedoman WHO berbasis GRADE (bukti sangat rendah pada rhodesiense)	**Fexinidazol oral kini lini pertama** pada kedua bentuk dan kedua stadium (fungsi lumbal tidak lagi wajib untuk staging rhodesiense). Suramin, melarsoprol, dan NECT di slide menjadi pilihan lain (NECT untuk anak di bawah 6 tahun, di bawah 20 kg, atau stadium 2 berat)
19	Cacing tambang, ascariasis	World Health Organization. Guideline: preventive chemotherapy to control soil-transmitted helminth infections in at-risk population groups. Geneva: WHO; 2017. ISBN 978-92-4-155011-6. Halaman WHO	Pedoman WHO berbasis GRADE (kualitas bukti banyak yang rendah)	Albendazol 400 mg atau mebendazol 500 mg dosis tunggal; kelompok sasaran termasuk ibu hamil **setelah trimester pertama**, sesuai catatan slide. Pedoman ini tentang program pengobatan massal, bukan terapi individual, dan ulasan Cochrane tentang deworming menyatakan bukti manfaat morbiditas terbatas
20	Strongiloidosis	Henriquez-Camacho C, Gotuzzo E, Echevarria J, White AC Jr, Terashima A, Samalvides F, et al. Ivermectin versus albendazole or thiabendazole for *Strongyloides stercoralis* infection. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(1):CD007745. DOI: 10.1002/14651858.CD0	Systematic review RCT (Cochrane), 7 RCT, 1147 peserta	**Ivermektin menyembuhkan lebih banyak daripada albendazol** (RR 1,79; bukti moderat) dengan tolerabilitas setidaknya sama; sesuai slide yang menjadikan ivermektin pilihan utama. Bukti untuk imunosupresi dan usia ekstrem belum cukup

No	Topik	Referensi (Vancouver)	Jenis dan tingkat bukti	Catatan EBM ter
		07745.pub3; teks di PMC		
21	Skabies	Rosumeck S, Nast A, Dressler C. Ivermectin and permethrin for treating scabies. Cochrane Database Syst Rev. 2018;(4):CD012994. DOI: 10.1002/14651858.CD012994; PubMed 29608022	Systematic review RCT (Cochrane), 15 studi, 1896 peserta	Ivermektin oral 200 mikrogram/kgBB **mungkin sedikit lebih rendah** kebersihan lesi pada minggu pertama dibanding permetrin 5% krim (RR 0,65; bukti rendah); pada minggu keempat ivermektin lotion setara permetrin. Mendukung slide: permetrin lini pertama
22	Filariasis	Macfarlane CL, Budhathoki SS, Johnson S, Richardson M, Garner P. Albendazole alone or in combination with microfilaricidal drugs for lymphatic filariasis. Cochrane Database Syst Rev. 2019;(1):CD003753. DOI: 10.1002/14651858.CD003753.pub4	Systematic review RCT (Cochrane)	Review ini mempertanyakan apakah albendazol memberi kontribusi penting pada eliminasi filariasis limfatik. **Kombinasi DEC + albendazol di slide berasal dari strategi program eliminasi**, bukan dari bukti tambahan yang kuat
23	Sistiserkosis (neurosistiserkosis)	White AC Jr, Coyle CM, Rajshekhar V, Singh G, Hauser WA, Mohanty A, et al. Diagnosis and treatment of neurocysticercosis: 2017 clinical practice guidelines by IDSA and ASTMH. Clin Infect Dis. 2018;66(8):e49-e75. DOI: 10.1093/cid/cix1084; teks di PMC	Pedoman profesi berbasis GRADE	Albendazol 15 mg/kgBB/hari 10 sampai 14 hari untuk 1 sampai 2 kista; **albendazol + praziquantel 50 mg/kgBB/hari** untuk lebih dari 2 kista viabel. Pada hidrosefalus atau edema otak, atasi tekanan intrakranial dulu, bukan antiparasit. Slide hanya membahas taeniasis dan pokok neurosistiserkosis
24	Toksoplasmosis	SYROCOT Study Group: Thiébaut R, Leproust S, Chêne G, Gilbert R. Effectiveness of prenatal treatment for congenital	Meta-analisis data pasien individual dan RCT	Terapi yang dimulai **dalam 3 minggu setelah serokonversi** menurunkan penularan ibu ke anak dibanding terapi yang dimulai 8 minggu atau lebih

No	Topik	Referensi (Vancouver)	Jenis dan tingkat bukti	Catatan EBM ter
		toxoplasmosis: a meta-analysis of individual patients' data. Lancet. 2007;369(9556):115-22. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)60072-5. RCT: Prenatal therapy with pyrimethamine + sulfadiazine vs spiramycin to reduce placental transmission of toxoplasmosis: a multicenter, randomized trial. Am J Obstet Gynecol. 2018;219(4):386.e1-9. DOI: 10.1016/j.ajog.2018.05.031		(OR 0,48). Perbandingan spiramisin dengan pirimetamin-sulfadiazin masih diperdebatkan; hasil RCT 2018 tidak saya baca lengkap
25	TB anak	World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 5: management of tuberculosis in children and adolescents. Geneva: WHO; 2022. ISBN 978-92-4-004676-4. Halaman WHO	Pedoman WHO berbasis GRADE	Memuat **pengobatan lebih pendek (4 bulan) untuk TB anak non-berat**, opsi baru untuk meningitis TB, dan alur keputusan terapi; menggantikan panduan 2014. Skoring dan rejimen 6 bulan di slide tetap dipakai di Indonesia, tetapi WHO sudah memberi opsi lebih pendek
26	Pertusis	Altunaiji S, Kukuruzovic R, Curtis N, Massie J. Antibiotics for whooping cough (pertussis). Cochrane Database Syst Rev. 2005;(1):CD004404. DOI: 10.1002/14651858.CD004404.pub2	Systematic review RCT (Cochrane)	Antibiotik **mengeliminasi bakteri** (pasien tidak menular) tetapi **tidak mengubah perjalanan klinis**; azitromisin 3 sampai 5 hari setara eritromisin 14 hari; kotrimoksasol alternatif bila tidak toleran makrolid. Versi 2007 (pub3) tercatat ditarik di salah satu basis data, jadi saya memakai versi 2005

No	Topik	Referensi (Vancouver)	Jenis dan tingkat bukti	Catatan EBM ter
27	Zinc pada diare anak	Lazzerini M, Wanzira H. Oral zinc for treating diarrhoea in children. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(12):CD005436. DOI: 10.1002/14651858.CD005436.pub5	Systematic review RCT (Cochrane), 33 RCT, 10.841 anak	Zinc bermanfaat pada anak **di atas 6 bulan** (memperpendek diare sekitar setengah hari; lebih besar pada malnutrisi) dan meningkatkan risiko muntah. **Pada anak di bawah 6 bulan tidak ada manfaat**, sehingga zinc 10 mg untuk usia di bawah 6 bulan pada slide tidak didukung review ini
28	Dengue (pembaruan)	World Health Organization. WHO guidelines for clinical management of arboviral diseases: dengue, chikungunya, Zika and yellow fever. Geneva: WHO; 2025. ISBN 978-92-4-011111-0. Halaman WHO	Pedoman WHO berbasis GRADE (MAGICapp)	Pedoman terbaru untuk tata laksana dengue, **menggantikan edisi 2009 untuk manajemen klinis**. Ringkasan sekunder menyebut penekanan pada pemantauan klinis (CRT, laktat, respons cairan) dan menghindari steroid, imunoglobulin, serta transfusi trombosit profilaksis; **isi lengkapnya perlu dibaca langsung** sebelum dikutip
29	Croup	Gates A, Gates M, Vandermeer B, et al. Glucocorticoids for croup in children. Cochrane Database Syst Rev. 2018;(8):CD001955. (Link langsung tidak muncul di hasil pencarian; cari nomor CD001955 di Cochrane Library.)	Systematic review RCT (Cochrane)	Glukokortikoid mengurangi gejala pada 2 jam, memperpendek rawat inap, dan menurunkan kunjungan ulang; **dosis, jenis, dan rute optimal masih belum pasti**. Ringkasan sekunder menyebut deksametason 0,15 mg/kgBB mungkin setara 0,6 mg/kgBB, sedangkan slide menulis 0,3 sampai 0,6
30	Bronkiolitis	Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, Alverson BK, et al. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics.	Pedoman AAP berbasis bukti	Terapi utama suportif. **AAP menganjurkan tidak memberi albuterol, epinefrin, maupun kortikosteroid sistemik**; foto toraks dan laboratorium tidak rutin. Karena itu "SABA nebul" yang tadinya

No	Topik	Referensi (Vancouver)	Jenis dan tingkat bukti	Catatan EBM ter
		2014;134(5):e1474-502. DOI: 10.1542/peds.2014-2742		saya tulis sudah diganti di tabel
31	CMV kongenital	Kimberlin DW, Jester PM, Sanchez PJ, Ahmed A, Arav-Boger R, Michaels MG, et al. Valganciclovir for symptomatic congenital cytomegalovirus disease. N Engl J Med. 2015;372(10):933-43. DOI: 10.1056/NEJMoa1404599	RCT tersamar ganda, 96 neonatus	Valganciclovir 16 mg/kgBB 2 kali sehari selama **6 bulan dibanding 6 minggu** tidak memperbaiki pendengaran jangka pendek, tetapi memperbaiki pendengaran dan perkembangan jangka panjang secara moderat. Sesuai slide